

Gravidez ectópica · diagnóstico e conduta

Ectópica = implantação fora do endométrio uterino (maioria tubária). Dor + sangramento + βhCG positivo exigem excluir ectópica; instabilidade = cirurgia.

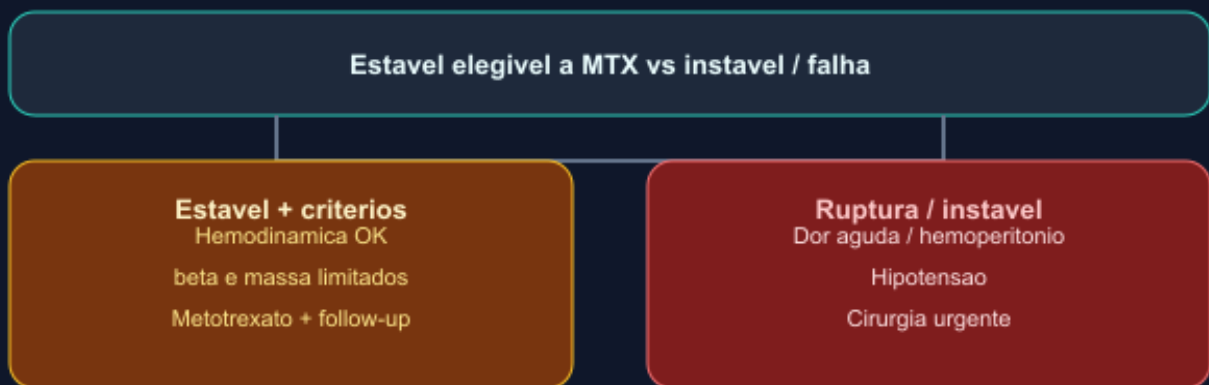
Diagnóstico

Dica - Diagnóstico

USG transvaginal: útero vazio com βhCG elevado F&T iminatório + massa anexial/líquido sugere ectópica. Discriminação: acompanhar curva de βhCG

Ramificação: estável com critérios ! metotrexato; ruptura/instabilidade ! laparoscopia/laparotomia.

Gestacao ectopica



Metotrexato — ideia de elegibilidade

- Estabilidade hemodinâmica e adesão ao seguimento
- βhCG muito elevado (cortes variam; banca cita limites clássicos)
- Sem ruptura, sem contraindicação hepático-renal/hematológica
- Seguimento obrigatório do βhCG

Conduta cirúrgica

Situação | Opção

Estável, desejo reprodutivo | Salpingostomia selecionada

Tubária destruída / sangramento | Salpingectomia

Instável | Via mais rápida disponível

Dúvida diagnóstica | Laparoscopia diagnóstica

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

βhCG 'em queda' não exclui ruptura iminente. Dor aguda + sinais peritoneais em mulher em idade fértil = protocolo de ectópica/hemoperitônio, não alta com analgésico.

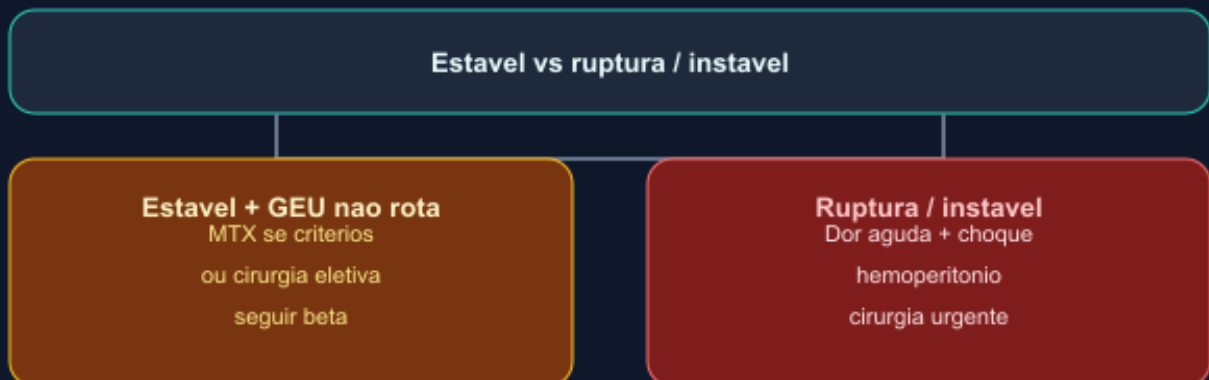
Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

GEU: zona discriminatória do βhCG $\geq 2 \times 6000$ -çG auterino; ruptura é emergência com peritonismo e choque.

Ramificação: conduta expectante/médica versus cirurgia de emergência.

GEU - estabilidade



Ideia da zona discriminatória do β -hCG ansvaginal.

Zona discriminatoria

beta-hCG vs saco IUP no US

beta ~1500-2000 + TVUS sem IUP => GEU?

Valor exato varia por servico; conceito e o que cai

Crítérios/sinais de ruptura (clássicos)

- Dor abdominal aguda intensa + defesa/peritonismo
- Sinais de hipovolemia/choque
- US: líquido livre abundante / hemoperitônio
- Colapso + sangramento vaginal variável (pode ser discreto)

Ideia diagnóstica

Ferramenta | Achado útil

β -hCG -> positivo; curva inadequada ou platô suspeito

TVUS | Útero vazio + massa anexial / saco ectópico / líquido

Zona discriminatória | β -hCG 6-8 -> β -hCG 10-20 -> alta suspeita de GEU

Culdcentese (clássico) | Sangue não coagulável — menos usado hoje

MTX — lembrar contraindicações

Atencao - MTX — lembrar contraindicações

Instabilidade, ruptura, contraindicação a metotrexato, massa grande/batimentos (conforme protocolo) !'
cirurgia, não MTX.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1